Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Campo Novo

Rua Fernandes de Araújo, 406 - Bairro: Centro - CEP: 98570-000 - Fone: (55) 3528-1447 - Balcão Virtual: (55) 9 9713-8124 - Email: frcamponovvjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM INFÂNCIA E JUVENTUDE Nº 5000921-70.2022.8.21.0088/RS

REQUERENTE: ARTHUR SCHMALZ GROHS
REQUERIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

ARTHUR SCHMALZ GROHS, menor incapaz, representado por sua genitora **TAIZE SCHMALZ GROHS** , ajuizou ação para fornecimento de medicamento, com pedido de tutela antecipada, em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, objetivando o fornecimento dos insumos para sistema de infusão contínua de insulina: Accu Chek Flexlink 8/60; Accu Chek Cânula 8 mm; Accu Chek Spirit 3,15ml; Accu Chek Performa; Accu Chek Lancetas Fastclix 204; Accu Chek Lancetas Fastclix 102; Accu Chek Service Pack Combo; Accu Chek Service Small Pack, por tempo indeterminado. Uma vez que é apresenta quadro de Diabete Mellitus (CID10 E14) (evento 1, INIC1).

Recebida a inicial e deferida a gratuidade judiciária. Concedida a tutela de urgência (evento 3, DESPADEC1).

Citado, o Estado do Rio Grande do Sul apresentou contestação (evento 21, CONT1) alegando, preliminarmente, que a União deve necessariamente figurar no polo passivo nas demandas em que se busca o fornecimento de medicamentos não padronizados no SUS, conforme Tema 793 do STF. Apontou a ausência de comprovação de efetividade do uso de tratamento não padronizado e excepcional de bomba de insulina, bem como o parecer desfavorável do CONITEC. Ao final, requereu a aplicação do tema 793 e do art. 109, inciso I, do CF; caso não acolhida a preliminar suscitada, seja julgada improcedente a pretensão formulada na exordial, ou solicitado parecer técnico do E-NATJUS e a intimação do(a) médico(a) assistente da parte demandante para que se manifeste acerca da necessidade de uso específico das marcas dos insumos postulados, em detrimento de outras disponíveis no mercado.

Sobreveio nota técnica emitida pelo Natjus com parecer favorável ao uso da bomba de insulina (evento 34, NOTATEC1).

Houve réplica, ocasião em que a parte autora rebateu a preliminar suscitada pelo Ente Público, reiterando os pedidos da exordial (evento 74, RÉPLICA1).

O Ministério Público apresentou parecer final opinando pela procedência da ação (evento 124, PARECER1).

Em suma, é o relatório.

Fundamento e decido.

1. Preliminarmente

Ressalto que o caso em voga não se enquadra no deslocamento de competência à Justiça Federal da tese fixada no julgamento do RE n.º 1366243/SC (Tema 1234 do STF), uma vez que o Supremo Tribunal Federal aplicou expressamente, em relação à competência jurisdicional, a incidência da referida tese apenas para processos ajuizados após a publicação da ata de julgamento (19/09/2024).

Logo, prevalece a solidariedade dos Entes Públicos no fornecimento da saúde ao cidadão, não podendo ser obstado o acesso de seus direitos fundamentais em razão da repartição administrativa das competências do SUS.

Passo a analisar o mérito.

2. Mérito

Da Assistência à Saúde e Jurisprudência aplicável

A Constituição Federal, em seu art. 5º, caput, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, garantiu o direito à vida e em seu art. 6º, que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros.

Não bastasse isso, o art. 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde e o dever do Estado. A Lei 8.080/90, em seu art. 2º, reiterou que a saúde é um direito fundamental do cidadão, incumbindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício, disciplinando o SUS – Sistema Único de Saúde - e incumbindo aos entes públicos a prestação de serviços de saúde à população.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu art. 241, preceitua que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, a se ofertada através de sua promoção, proteção e recuperação.

É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhecendo o dever do Estado, lato sensu considerado, ou seja, modo indistinto por todos os seus entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – de assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 23, II e 196, ambos da Constituição Federal.

O acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade.

Recentemente, com o julgamento dos Temas 1234 e 06, o Supremo Tribunal Federal editou as Súmulas Vinculantes 60 e 61, atinentes à disponibilização de medicamentos:

> *Súmula vinculante 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).*
>
> *Súmula vinculante 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).*

De acordo com a tese fixada no Tema 1234 do STF, ficou determinado que:

> *"[...] O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.234 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e homologou, em parte, os termos dos 3 (três) acordos, com as condicionantes e adaptações, assim sintetizados como as teses fixadas no presente tema da sistemática da repercussão geral, a saber:*
>
> (...)
>
> *II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.*
>
> (...)
>
> *IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.*
>
> (...)
>
> *VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão" [...]" (grifei).*

Por sua vez, o Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), fixou parâmetros para apreciação de pedidos de medicamentos não incorporados:

> *A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Grifou-se.*

No julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 1.366.243/SC, o Min. Gilmar Mendes esclareceu:

Nestes termos, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024).

Assim, nos termos do art. 987, §2º, do CPC, a tese jurídica fixada pelo STF tem aplicação imediata, independentemente de trânsito em julgado. E os efeitos modulatórios da decisão, no caso, foram estabelecidos somente no que respeita à regra de competência.

Da prova da moléstia, da ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS e da necessidade do tratamento postulado.

A prestação jurisdicional, todavia, não pode deixar de considerar a situação individualizada de cada caso.

Em análise objetiva, os insumos postulados nesta ação possuem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mas não está incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento do diagnóstico apresentado pela parte autora. Ainda, não há análise de pedido de incorporação pela Conitec.

O relatório médico juntado (evento 1, OUT15) atesta que a parte autora é portadora de Diabete Mellitus tipo 1 (CID10 E14) e necessita dos insumos para sistema de infusão contínua de insulina (bomba de insulina) por tempo indeterminado.

O paciente foi diagnosticado em abril de 2017, quando tinha 3 (três) anos de idade, quando precisou ficar em internação hospitalar por 7 (sete) dias para diagnóstico e tratamento inicial. Após estabelecimento da doença, paciente iniciou controle e tratamento através de múltiplas doses de insulina.

O tratamento iniciou com insulina do tipo Novorapid (asparte) e Lantus (glargina), com melhora da adesão ao tratamento, porém mantendo episódios freqüentes de hipoglicemias e hiperglicemias moderadas à graves.

O paciente também apresenta desde o início do tratamento muitas variações glicêmicas, ocasionadas pela dificuldade de administração de insulina através de canetas e seringas. O tratamento disponível consiste em injetar insulina para garantir um controle glicêmico adequado e com isso evitar o aparecimento das graves complicações que reduzem a expectativa de vida e comprometem a qualidade de vida do portador desta doença.

Apesar de todos os procedimentos realizados, as insulinas administradas por canetas aplicadoras não conseguem mimetizar a secreção endógena de insulina, o que pode determinar episódios de variações de glicemia, como níveis muito altos e hipoglicemias severas com risco de crises convulsivas, principalmente noturnas, as quais podem determinar risco de morte, caso não seja percebido pela família ou responsável em tempo hábil.

Ademais, após consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sobreveio Nota Técnica favorável ao fornecimento dos medicamentos (evento 34, NOTATEC1):

Tecnologia: *Bomba de Insulina Minimed*

Conclusão Justificada: *Favorável*

Conclusão: *CONSIDERANDO o diagnóstico de DIABETES MELITO TIPO 1, conforme relatórios médicos acostados ao processo.*

CONSIDERANDO a presença de episódios repetidos de HIPOGLICEMIA GRAVE e CONTROLE GLICÊMICO IRREGULAR usando as formulações de insulina disponíveis no mercado.

CONSIDERANDO a evidência em literatura médica de benefícios da BOMBA DE INSULINA em situações análogas à do paciente solicitante.

CONCLUI-SE que HÁ ELEMENTOS para sustentar a indicação de BOMBA DE INSULINA no caso em questão na presente solicitação.

Outrossim, conclui-se que a parte autora, efetivamente, não possui condições de arcar com o custo dos insumos, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, levando em consideração a declaração de hipossuficiência financeira (evento 1, DECLPOBRE13), e o valor do insumos conforme orçamentos juntados aos autos.

Presentes, pois, os requisitos estabelecidos na tese fixada no julgamento do Tema 106 pelo e. STJ, in verbis:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência

Portanto, demonstrada a incapacidade econômica da parte autora, a necessidade do tratamento postulado como condição para a preservação da própria vida, a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do direito à saúde é medida que se impõe, sob pena de esvaziamento da norma constitucional.

Dispositivo

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, com resolução de mérito, **julgo PROCEDENTE** o pedido formulado por **ARTHUR SCHMALZ GROHS**, representado por sua genitora TAIZE SCHMALZ GROHS em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, para condenar o réu a fornecer os insumos para sistema de infusão contínua de insulina: Accu Chek Flexlink 8/60; Accu Chek Cânula 8 mm; Accu Chek Spirit 3,15ml; Accu Chek Performa; Accu Chek Lancetas Fastclix 204; Accu Chek Lancetas Fastclix 102; Accu Chek Service Pack Combo; Accu Chek Service Small Pack, por tempo indeterminado, devendo a parte autora renovar o receituário médico a cada seis meses.

Sucumbente o Ente Público, condeno ao pagamento das custas e despesas do processo e de honorários ao procurador do requerente, a serem depositados em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado - FADEP, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, forte no art**.** 85, § 2º do CPC, considerando o tempo de tramitação do feito e o trabalho que se fez necessário. Isento do pagamento de custas processuais, devido apenas as despesas.

Observado o disposto no art. 11 da Lei nº 12.153/2009, a sentença não está sujeita à remessa necessária.

Publicação, registro, intimações pelo sistema eletrônico.

Certificado o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA RECH SLAVIERO PORATH BONIOTTI, Juíza de Direito**, em 23/07/2025, às 01:34:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10086039313v5** e o código CRC **63ad46c5**.